Manejo del dolor durante la lactancia

Dolor en ginecología y paciente obstétrica

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Dolor a nivel del pezón

Síntomas.
Causas.
¿Cómo abordar el dolor en los pezones y en las mamas durante el amamantamiento?

4. Mastitis

5. Fármacos analgésicos seguros durante la lactancia

6. Bibliografía

Objetivos

- Describir dos de las patologías dolorosas más frecuentes que aparecen durante la lactancia: las lesiones en el pezón (fisuras o grietas) y la mastitis.
- Reconocer los fármacos analgésicos que podrían ingerirse en una madre lactante para el tratamiento de cualquier tipo de dolor.

Introducción

La lactancia materna (LM) es la forma más adecuada para proporcionar los nutrientes que necesita el recién nacido para su crecimiento. Siendo precisamente la leche materna un elemento vivo único e irrepetible que contiene los nutrientes específicos que requiere el bebé para su mejor desarrollo integral. El recién nacido necesita de la presencia de su madre para sobrevivir. Si no recibe alimento, muere físicamente, si no recibe contacto, no se desarrolla emocionalmente.

El único alimento que debe recibir el bebé durante los primeros 6 meses de vida es la leche de su madre. Cualquier sustancia que ella consuma mientras esté lactando tiene repercusiones en su hijo, por lo que la utilización de medicamentos, fitofármacos u otras sustancias debe ser por prescripción facultativa y rigurosamente vigilada (1).

En el pecho de su madre se conjuga la satisfacción de estas dos necesidades imperantes: amor y afecto en la misma cantidad. Un bebé amamantado pasa muchas más horas entre los brazos de su madre y esto le brinda la oportunidad de tener el contacto piel a piel y con los sentidos que están aún en desarrollo. Una madre que amamanta a su hijo le da la oportunidad de olerla, probarla, sentirla, escucharla, establecer mayor contacto cara a cara, reafirmar al bebé su existencia a través de la mirada y el contacto materno (Figura 1).

Figura 1. Tomado de Pixabay. https://pixabay.com/es/photos/amamantar-amamantamiento-mam%c3%a1-1570695/

Durante el inicio de la LM muchas madres van a experimentar dolor por la aparición de complicaciones, generando un estrés psicológico materno, con alteraciones del estado de ánimo, lo que podría llevar a una retirada precoz de la LM si no se realiza un tratamiento adecuado. Pero, además, de forma positiva, la lactancia materna provoca la liberación de hormonas en la madre (prolactina, oxcitocina, cortisol) que actúan como ayudantes biológicos para promover sentimientos maternales y agudizar su intuición.

Sentimientos e intuición, además de la observación y el ensayo – error, le facilitarán desarrollar la capacidad de reconocer y anticipar las necesidades que su bebé tiene y que es aún incapaz de expresar más que a través del llanto o de señales muy particulares que la madre sabrá interpretar (2).

El Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría (2012) define la lactancia como un fenómeno cultural con implicaciones biológicas determinantes para la supervivencia de la especie humana. "El amamantar garantiza la disponibilidad de alimento seguro, suficiente, gratuito, de insustituible calidad y a la medida de los requerimientos nutricionales de los bebés". Les protege de infecciones y enfermedades en una etapa de sus vidas en las que se encuentran particularmente vulnerables, a la vez que crea un vínculo que les confiere a niños, niñas y sus madres, salud física y emocional, además de protección, seguridad y afecto. Todas ellas, condiciones indispensables para un pleno desarrollo infantil (3).

A largo plazo, los niños no amamantados padecen con más frecuencia dermatitis atópica, alergia, asma, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, Diabetes Mellitus, esclerosis múltiple y cáncer. Las niñas no amamantadas tienen mayor riesgo de cáncer de mama en la edad adulta. Los lactantes no alimentados al pecho presentan peores resultados en los test de inteligencia y tienen un riesgo más elevado de padecer hiperactividad, ansiedad y depresión, así como de sufrir maltrato infantil.

Por otro lado, en las madres que no dan lactancia aumenta el riesgo de padecer hemorragia postparto, fractura de columna y de cadera en la edad postmenopáusica, cáncer de ovario, cáncer de útero, artritis reumatoide, enfermedad cardiovascular, hipertensión, ansiedad y depresión (3).

Sin embargo, durante el inicio de la lactancia materna, muchas de ellas van a experimentar dolor, por la aparición de complicaciones como grietas en el pezón, mastitis, ingurgitación mamaria, congestión mamaria, obstrucción del conducto galactóforo (galactocele), dermatitis de la mama, etc., lo que podría llevar a una retirada precoz de la lactancia materna si no se realiza un tratamiento adecuado.

La mastitis puerperal es una de las complicaciones más frecuente durante la lactancia materna. Generalmente es de origen bacteriano. Su prevalencia oscila entre el 2-33 % de mujeres lactantes. Debuta más frecuentemente entre la 2º y 6º semana postparto. Aproximadamente el 3-10 % de los cuadros de mastitis aguda desarrollan un absceso mamario (4) *(Figura 2).*

Figura 2. Pezón agrietado. Tomado de: pezones secos (escamosa agrietada, picazón en la piel): causas y remedios caseros. Por: Kylie López. https://elutil.com/remedios-caseros/pezones-secos-escamosa-agrietada-picazon-en-la-piel-causas-y-remedios-caseros/

Sobre el dolor y las lesiones en el pezón

La lactancia materna, además de desempeñar un papel importante para la salud y desarrollo tanto de la madre como de su hijo, proporciona la mejor nutrición para el niño. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses, complementada después con alimentos sólidos hasta la edad de dos años, con el objetivo del bienestar biológico y social del bebé y su madre.

Aproximadamente entre el 34-96 % de las pacientes que dan lactancia materna experimentan algún tipo de dolor a nivel del pezón durante las primeras semanas, lo cual podría llevar a la retirada de la lactancia materna. Una lactancia materna óptima tiene tal importancia que permitiría salvar la vida de más de 820 000 menores de 5 años todos los años.

La OMS y UNICEF recomiendan lo siguiente (5):

- Inicio inmediato de la lactancia materna en la primera hora de vida.
- Lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida.
- Introducción de alimentos complementarios seguros y nutricionalmente adecuados a partir de los seis meses, continuando la lactancia materna hasta los dos años o más.

Síntomas

Desafortunadamente, muchas mujeres experimentan dolor y lesiones en el pezón durante la lactancia. Los síntomas del dolor y lesiones del pezón incluyen: dolor, enrojecimiento, grietas, hinchazón, descamación, sangrado, ampollas, marcas, costras o secreciones. Estas complicaciones están consideradas como los factores más importantes que impiden a las madres amamantar a sus bebés durante las primeras semanas de la maternidad. Hasta un tercio de las madres que experimentan estos síntomas pueden cambiar a métodos alternativos para alimentar a sus bebés en las primeras seis semanas de vida *(Figura 3).*

Figura 3. Eczema del pezón. Tomado de: imágenes de eczema del pezón. DermNet. https://dermnetnz.org/topics/nipple-eczema-images

Causas

Existen varias posiciones diferentes para dar de mamar a un bebé. Una buena posición de lactancia, tanto de la madre como del hijo, y una técnica correcta de agarre del bebé, son factores importantes para una lactancia exitosa. Las malas posturas y la técnica de agarre incorrecta se han identificado como las causas de dolor y lesiones en el pezón. La educación pre-parto y pos-parto puede ayudar con las posturas y la técnica de agarre del bebé para prevenir el dolor y las lesiones en el pezón *(Tabla 1).*

¿Cómo abordar el dolor en los pezones y en las mamas durante el amamantamiento?

Para abordar el dolor en los pezones y en las mamas durante el amamantamiento, lo primero que hay que hacer es valorar a la madre y el lactante, explorando las mamas y la anatomía oral del niño, así como observar, en una toma la postura, el agarre y la existencia de transferencia de leche (2).

La guía NICE recomienda advertir a las mujeres que, si tienen dolor en el pezón o estos están agrietados, es probable que se deba a un mal agarre. El incremento de la lactancia materna (LM) como la alimentación más natural y saludable en el recién nacido y lactante, ha comportado la necesidad de un mayor conocimiento de la anquiloglosia. Se define anquiloglosia a la presencia de un frenillo sublingual que limita la movilidad de la lengua. El cirujano pediátrico debe aumentar su conocimiento y saber tratarla (6).

El bebé con anquiloglosia tiene un frenillo lingual anormalmente corto, engrosado o apretado que muestra una alteración en su inserción y fijación, generalmente cerca de la punta de la lengua. Los niños con anquiloglosia pueden tener una movilidad restringida de la lengua, lo que resulta en dificultades para hablar o alimentarse. La anquiloglosia está presente en el 0,1 % al 11 % de los recién nacidos. Los factores de riesgo incluyen ser hombre (3:1) y antecedentes familiares positivos.

La anquiloglosia se ha asociado con problemas de lactancia debido a la dificultad para adherirse o permanecer sujeto al pecho, y al dolor del pezón materno. El diagnóstico depende de la evaluación de la estructura y la función del frenillo lingual, que varía desde una simple inspección visual y/o palpación del frenillo hasta un sistema más complejo de clasificación en varias escalas. Por lo que cada neonato con anquiloglosia causa dolor en las mamas de su madre durante la lactancia materna, por la presencia de un frenillo sublingual que cambia la apariencia o la función de la lengua del bebé, debido a que su longitud se encuentra disminuida, además presenta un deterioro en la elasticidad, encontrándose muy cerca de la cresta gingival y adoptando, muchas veces, forma de corazón durante la protrusión. En los últimos años, con el fomento de la lactancia materna como principal modo de alimentación del lactante, la justificación de la frenotomía ha pasado de mejorar los problemas de habla a mejorar la lactancia materna (7).

Este padecimiento impide al bebé ampliar y elevar la parte anterior de la lengua, alterando así el movimiento peristáltico de esta durante la alimentación, lo que puede provocar, a su vez, lesiones en el pezón y problemas con la transferencia de leche para los y las lactantes, perjudicando el aumento eficaz de peso. Este es, pues, una causa directa de lesiones en el pezón de la madre (6) *(Figura 4).*

Existen dos tipos de tratamiento para la anquiloglosia: el conservador y el quirúrgico. Este se escoge dependiendo del criterio médico y de la etapa en que se encuentre el o la niña, además de las dificultades que este padecimiento acarrea para el correcto desarrollo del niño o niña. Si con las medidas de apoyo que se instauren los problemas persisten, se debería realizar una frenotomía por profesionales expertos para mejorar la efectividad de la lactancia (6), (8).

Figura 4. Anquiloglosia. Tomado de: Lazo de lengua. Por: Abu Shaaba. My baby clinic. http://mybabyclinic.com/en/news/132/tongue-tie.html

Etiología del dolor a nivel del pezón	
Más frecuentes (dolor inicial o transitorio del pezón)	Menos frecuentes (dolor prolongado y persistente)
• Succión en vacío de los conductos	• Mala colocación del recién nacido al pecho
• Compresión brusca del pezón	• Incorrecta retirada del bebé
• Congestión vascular del pezón	• Uso de cremas que puedan irritar la piel y formar fisuras o ulceraciones

Tabla 1. Etiología del Dolor a nivel del pezón.

La frenotomia es una simple incisión del frenillo lingual; la frenectomía es la eliminación del frenillo lingual (7).

La identificación del dolor asociado a la LM, así como un control adecuado, son claves para el mantenimiento de la lactancia. A continuación, se describirán dos de las patologías dolorosas más frecuentes que aparecen durante la lactancia: las lesiones en el pezón (fisuras o grietas) y la mastitis. También, se hablará de los fármacos analgésicos que podrían administrarse en una madre lactante para el tratamiento de cualquier tipo de dolor.

En el caso de dolor inicial o transitorio del pezón se recomienda valorar y facilitar la posición y el agarre, así como aplicar leche materna extraída o agua caliente sobre el pezón tras el amamantamiento y dejar secar. En el caso de dolor prolongado y persistente, se aconseja, además, empezar a amamantar del pecho que presenta el pezón menos afectado y dejar la lactancia del pecho afectado solo cuando el dolor es insoportable, realizando extracción manual durante este tiempo para mantener la producción de leche, rectificar el uso inapropiado de los extractores de leche y dejar de utilizar cremas, geles u otros posibles irritantes (2) *(Figura 5).*

La guía NICE señala que las mujeres con pezones invertidos deberían recibir apoyo y cuidados adicionales para asegurar el éxito de la lactancia materna. A las mujeres con pezones planos o invertidos se les debería informar de que la lactancia materna no está contraindicada. Se debe posicionar al lactante para que alcance un agarre profundo.

También indica que se puede utilizar una pezonera de silicona ultra delgada para la lactancia, y que, si todavía no se consigue un buen agarre, se puede extraer la leche materna y alimentar al lactante hasta que el agarre sea posible. El pezón grande presenta problemas de lactancia materna en pocas ocasiones, generalmente, cuando el bebé es inmaduro o de pequeño tamaño. En estos casos es esencial una intervención inmediata (2).

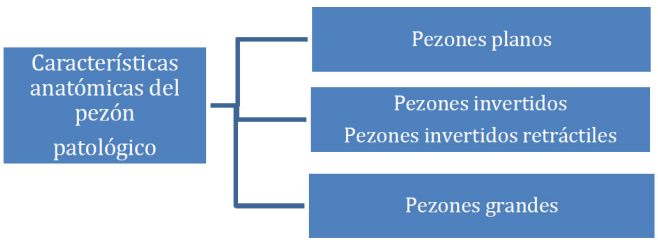

Figura 5. Características anatómicas del pezón patológico.

El tratamiento preventivo es el siguiente:

- Se recomienda que los pezones estén secos, no lavarse tras las tomas. Ordeñárse un poco de leche sobre los pezones y dejarlos secar al aire libre.
- El uso del sacaleches es recomendable, pero controlando la presión que se ejerce sobre el pezón.
- Una buena educación antenatal y postnatal del correcto posicionamiento de la madre y recién nacido. Un buen agarre del bebé ha demostrado que disminuye la incidencia de grietas y dolor en las mujeres.

  Es importante que la técnica de lactancia sea adecuada, que el bebé esté enfrentado a la madre (barriga con barriga), que el bebé introduzca la mayor parte de la areola y con el labio inferior evertido. Las mejillas deben estar redondas o aplanadas (no hundidas) y el mentón del bebé debe tocar el pecho de la madre. De esta forma se producirá un vaciado correcto del pecho, con una producción adecuada de leche, sin aparecer dolor durante la LM.

En cuanto al **tratamiento local,** se han descrito diferentes alternativas tópicas para el daño producido por la LM en el pezón. Se han utilizado soluciones, cremas o ungüentos para secar, hidratar y endurecer el pezón, como la lanolina, lanolina altamente purificada (LAP), apósitos hidrogel, protectores de silicona, aerosoles antibacterianos (ej. clorhexidina al 0,2 % / Alcohol), colagenasa o dexpantenol. También se ha utilizado el secado al aire, la luz ultravioleta, así como la aplicación de compresas calientes.

Si a pesar de los tratamientos conservadores (tratamiento tópico, corrección de la técnica, etc.) el dolor continúa, se debe descartar otros problemas como el frenillo lingual corto (anquiloglosia) o vasoespasmo/síndrome de Raynaud.

- La anquiloglosia en el recién nacido presenta una incidencia del 0,02-10,7 %, y podría dificultar la LM al no conseguir un agarre profundo por el movimiento limitado de la lengua. En estos casos se debería valorar realizar una frenectomía con tijeras o láser, para mejorar el agarre de succión y resolver el dolor.

- Respecto al vasoespasmo, la incidencia suele ser aproximadamente del 22 % en las primeras 8 semanas postparto, en las mujeres que estaban dando lactancia. El tratamiento que se propone en estas situaciones es dar calor en la zona (compresas, almohadillas térmicas), AINES y el uso de nifedipino de liberación sostenida a diario (30-60 mg) o de liberación inmediata (10-20 mg) tres veces al día durante 2 semanas como mínimo.

Mastitis

La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria, y suelen presentarse en el 33 % de las mujeres con LM, afectando a uno o varios lóbulos, acompañándose o no de infección. Suele presentarse entre la 2-3ª semana postparto, siendo las primeras 12 semanas el periodo de mayor incidencia. Surge a partir del drenaje inadecuado del seno, lo cual conduce a congestión mamaria y estasis láctea. La prevalencia es mayor durante el puerperio, sin embargo, también puede ocurrir en cualquier otro momento. Es una enfermedad debilitante, que con frecuencia resulta en interrupción de la lactancia materna. Se clasifica según el curso, las manifestaciones clínicas y si ocurre durante el periodo de lactancia.

Durante la lactancia, la mastitis suele ser consecuencia de un proceso de disbiosis. Se han aislado el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y ciertas corinebacterias como principales agentes etiológicos. Existen otras etiologías de mastitis que no guardan relación con la lactancia y el puerperio, pero estas abarcan la minoría de los casos. El dolor es el síntoma más frecuente. Sin embargo, puede venir acompañado de síntomas sistémicos (similares a la gripe, mialgias, y fiebre) (9) *(Tabla 2).*

Causas de la mastitis
• Obstrucción conducto galactóforo
• Sobreproducción de leche
• Uso de extractor de leche
• Presión sobre el pecho que dificulta drenaje
• Cambios en frecuencia de alimentación
• Destete lactancia materna
• Fisura pezón

Tabla 2: Causas de la mastitis.

Aunque existe heterogeneidad en la clasificación, en general, se distinguen dos tipos de mastitis puerperal (aguda y subaguda) que se diferencian tanto en la etiopatogenia, como en su debut clínico y manejo. En la mastitis aguda existe una infección de la mama procedente de las mucosas o la piel, viéndose favorecida por la presencia de soluciones de continuidad (erosiones o fisuras). La mastitis subaguda representa una disbiosis de la microbiota de la mama que se produce en los conductos galactóforos formando un biofilm que genera obstrucción (10).

La mastitis aguda suele producirse por la ectasia láctea secundaria a técnicas incorrectas en la colocación del pecho o en la frecuencia de las tomas. Esto ocasiona un vaciado incompleto de la mama, derivado en un acúmulo de leche que favorece la infección bacteriana. Asimismo, la presencia de grietas debidas a un agarre incorrecto constituye una puerta de entrada microbiana (9),(10) *(Figura 6).*

No es posible distinguir solamente con la clínica entre una mastitis no infec-ciosa y una mastitis infecciosa, y ante un cuadro de este tipo, lo que debería llevar a sospechar una infección sería lo siguiente (2) *(Figura 7):*

Los factores desencadenantes de un inadecuado drenaje de la glándula mamaria (estancamiento de leche), pueden facilitar el crecimiento bacteriano. La lesión producida en el pezón (fisuras) por la LM permitirá la entrada de microorganismos debido a la pérdida de la barrera epitelial (9) *(Figura 8).*

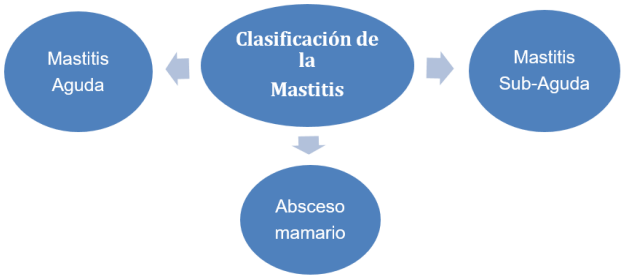

Figura 6. Clasificación de la Mastitis.

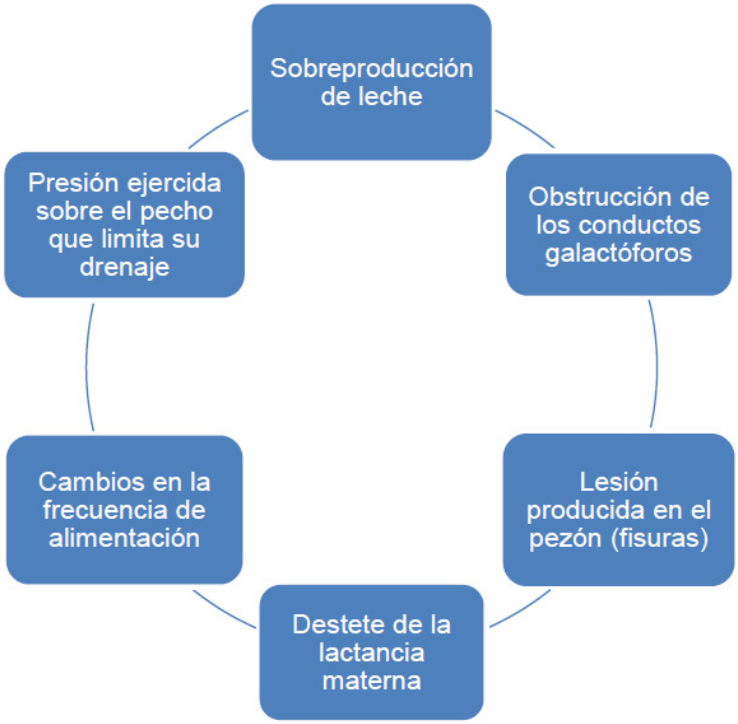

Figura 7. Factores desencadenantes de un inadecuado drenaje de la glándula mamaria.

Figura 8. Mastitis.

Se debe sospechar de la existencia de infección mamaria si se presenta lo siguiente (2):

- Síntomas agudos en la mama, como inflamación o edema, calor y aumento de la sensibilidad o dolor.
- Síntomas generales como malestar, fiebre de más de 38,5 ºC, escalofríos y dolor de cabeza.
- Dolor profundo en la mama durante la toma o después de la misma que no resuelve tras la evaluación e intervención por profesionales expertos en lactancia materna que descarten y traten otras posibles causas de la mastalgia.
- Si la mujer presenta fisuras infectadas en el pezón.
- Si el resultado del cultivo de la leche materna es positivo.

Se debe confirmar mastitis infecciosa cuando hay presencia y persistencia de sensibilidad, inflamación, enrojecimiento, calor y disminución en la producción de leche, así como un nivel de leucocitos superior a 106, y 103 bacterias por ml de leche materna. En un 80 % de las pacientes aparecerán grietas e irritación en el pezón con intenso dolor.

Puede acompañarse o no de infección, es decir, puede estar implicada una causa no infecciosa o a una infección bacteriana y cuyo espectro clínico puede ir desde la presencia de inflamación local con síntomas sistémicos mínimos al absceso y la sepsis. Habitualmente se asocia con la lactancia (causa no infecciosa), así que también se la conoce como mastitis de la lactancia o mastitis puerperal. Puede ser mortal si se trata de manera inadecuada. Con relación en esta patología, la Association of Breastfeeding Medicine (ABM) (11) apunta a que aparentemente existe un continuum que va de la congestión a la mastitis no infecciosa, que evoluciona a mastitis infecciosa y de ahí al absceso mamario.

En caso de sospecha de mastitis aguda infecciosa, se debe valorar el inicio precoz del tratamiento antibiótico, manteniendo la lactancia y el vaciado adecuado del pecho. La aplicación de calor local con agua tibia antes de realizar una toma puede facilitar el flujo de la leche, y la aplicación de frío entre tomas puede ser útil por su efecto antiinflamatorio. Se aconseja tomar analgésicos compatibles con la lactancia materna, como paracetamol e ibuprofeno, hacer reposo y aumentar la ingesta de fluidos. Se debe realizar una reevaluación a las 48-72 horas para comprobar la respuesta al tratamiento, puesto que la adición empírica de un antibiótico no garantiza la resolución del cuadro.

En caso de evolución desfavorable a pesar del tratamiento, se podría realizar una ecografía mamaria para descartar la existencia de abscesos u otras patologías mamarias como el cáncer mamario (9).

Etiología

De acuerdo con la publicación de la OMS sobre la mastitis, las dos principales causas de la misma son la estasis de la leche (EL) y la infección, siendo la primera, habitualmente la causa principal, pudiendo acompañarse o progresar hacia la infección o no. La EL ocurre cuando la leche no se extrae del pecho de manera eficaz. Las causas incluyen mal agarre del niño al pecho, succión ineficaz, restricción de la frecuencia o duración entre una toma y otra y el bloqueo de los conductos lácteos. Otras situaciones que puede predisponer a la estasis de la leche incluyen una sobreproducción de leche, o el estar lactando a gemelos o a más niños productos de partos múltiples. Además, en el caso de las infecciones, los microorganismos que la causan con mayor frecuencia son el Staphylococcus aureus siendo el responsable al menos del 75 % de los casos de mastitis infecciosas sintomáticas. En los últimos años, se ha puesto de manifiesto que los estafilococos coagulasa-negativos, como S. epidermidis también son causa importante de mastitis infecciosa.

El segundo grupo bacteriano implicado en estos procesos infecciosos es el de los estreptococos, ya que, solos o asociados a estafilococos, se encuentran en un 10-15 % de los cuadros de mastitis, entre los más frecuentemente aislados están: Streptococcus mitis, S. salivarius e incluso, S. pneumoniae.

Los géneros *Staphylococcus y Streptococcus* son los principales agentes etiológicos. *Staphylococcus aureus* (generalmente meticilin-sensible) suele ser responsable de las mastitis agudas y la formación de abscesos, mientras que los *Staphylococcus coagulasa* negativos, especialmente *Staphylococcus epidermidis*, son la principal causa de mastitis subaguda (10) *(Tabla 3).*

Ante la sospecha de infección, realizar un cultivo en las siguientes situaciones (2):

- No hay respuesta tras 48 h de tratamiento antibiótico empírico apropiado.
- Siempre antes de cualquier prescripción antibiótica en caso de mastitis grave (sepsis o shock séptico, absceso mamario, necesidad de ingreso hospitalario).
- Mastitis recurrente.
- Mastitis de adquisición nosocomial o con factores de riesgo de *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (SARM).
- Alergia a penicilina con intolerancia a cefalosporinas.
- Hay un dolor profundo severo con sensación de quemazón "en la mama (indicativo de infección ductal).

Tratamiento

De acuerdo con la publicación de la OMS, el protocolo vigente de la ABM sobre mastitis y el Manual de Implementación de Clínicas de Lactancia Materna, la mastitis se puede manejar desde tres campos de acción *(Figura 9):*

- **Medidas de apoyo o prevención.**

  Se debe evitar el éstasis de leche ofreciendo lactancia materna a libre demanda, alargando cada toma, evitando el uso de ropa o posturas que compriman el pecho, masajeando y dando calor local antes de alimentar al bebé, lo cual puede ayudar a que fluya la leche con más facilidad, y si el vaciado es incompleto, ayudarse con un sacaleches o de forma manual.

  Es importante que la madre reciba una buena educación, tanto para la extracción de leche como para la exploración de la mama, facilitando de esta forma que sea capaz de identificar una estasis, ingurgitación e inflamación de la mama. También es importante la higiene de manos y del extractor de leche.

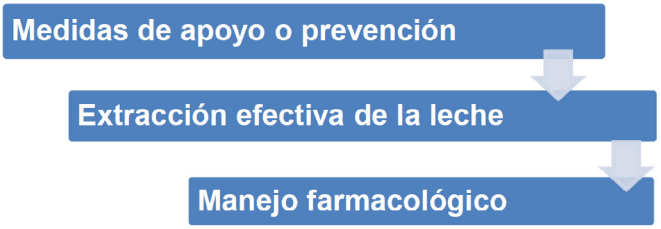

Figura 9. Pilares terapéuticos de la Mastitis.

Caracterización de las formas clínicas de la Mastitis		
Mastitis aguda	**Absceso mamario**	**Mastitis subaguda**
- Mama inflamada con área sensible o dolorosa, caliente y roja. Suele ser unilateral - Puede acompañarse de malestar, artromialgias, fiebre >38,5ºC, escalofríos, cefalea, etc.	- Masa palpable, fluctuante, asociada a fiebre y toma del estado general, que no mejora con antibioterapia	- Suele ser diagnóstico de exclusión - Dolor profundo en la mama durante la toma o después de la misma que persiste tras descartar otras posibles causas de mastalgia - No hay síntomas generales ni fiebre - La exploración física suele ser normal

Tabla 3. Caracterización de las formas clínicas de la Mastitis.

En el caso de presentar grietas en el pezón, con eritema, exudación o retraso en su cicatrización, se podría aplicar un antibiótico tópico (mupirocina 2 %), y en caso de no mejoría iniciar tratamiento sistémico.

Por otra parte, una vez que se ha alimentado al bebé o se ha extraído la leche de los pechos, se puede proceder a la aplicación de compresas frías en el pecho con el objeto de reducir el dolor y el edema.

- **Extracción efectiva de la leche.**

  Si se toma en cuenta que la estasis láctea constituye el factor que da inicio a la mastitis, el paso más importante en su manejo radica en la extracción frecuente y efectiva de la leche. Resulta de suma importancia el ayudar a la madre a mejorar el agarre de su hijo al pecho y animarle a amamantar frecuentemente, tan a menudo y tanto tiempo como el niño esté dispuesto a hacerlo. Se sugiere la realización de masajes en el pecho antes o durante la extracción, la utilización de técnicas de relajación, así como la aplicación de calor en el pecho, independientemente del método de extracción considerado, para conseguir aumentar el volumen de leche extraída (2) *(Figura 10).*

El manejo farmacológico de la mastitis se basa en el alivio sintomático y la terapia antibiótica. constatado

- En cuanto al manejo sintomático, la analgesia puede ayudar al reflejo de eyección de la leche y deberá fomentarse. Como analgésicos o antiinflamatorios de elección, destacar el ibuprofeno (400-600 mg/6-8 h), con una excreción en leche mínima (0,2 %), el cual va a disminuir la inflamación, calmar el dolor y facilitar la eyección de leche, sobre todo si el dolor va asociado a un proceso inflamatorio. El ibuprofeno, 400 mg cada 6 o 8 horas VO, puede ayudar a reducir tanto la inflamación como el dolor. También, será necesario pautar antitérmicos, como el paracetamol, el cual también contribuirá a controlar el dolor.

Figura 10. Extracción efectiva de la leche. Tomado de Pixabay. https://pixabay.com/es/photos/amamantamiento-madre-maternidad-2428378/

- Para la terapia antibiótica empírica de mastitis agudas que no responden a las medidas conservadoras, se recomienda el uso de cefalosporinas de primera generación (cefalexina 500 mg cada 6 horas, vía oral o cefadroxilo), cloxaciclina o amoxiciliana-clavulánico durante 10 a 14 días. Estas opciones deben cubrir los dos gérmenes más frecuentemente encontrados, que son el *Staphylococcus aureus*, y, menos frecuentemente, el Streptococcus del grupo B.

Si la madre es alérgica a los betalactámicos o se sospecha una infección por *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (SARM), se administrará clindamicina, vacomicina o linezolid. Cuando el lactante tenga más de 4-6 semanas de vida, puede utilizarse también trimetroprim sulfametoxazol 480 mg cada 12 horas.

El tratamiento con probióticos es más eficaz que el tratamiento con antibióticos en reducir la puntuación del dolor en las mamas y la recurrencia de los síntomas a los tres meses de haber conseguido valores fisiológicos normales en mujeres con presencia de inflamación de la mama, una lactancia dolorosa, un nivel de unidades formadoras de colonias (UFC) por ml mayor a 4 log 10 en la leche materna y de leucocitos mayor a 6 log10) (2).

En caso de abscesos mamarios menores de 5 cm de diámetro, el drenaje por aguja bajo control ecográfico es igual de eficaz que el drenaje por cirugía en la curación del absceso, necesitando, además, un menor tiempo de curación. A la hora de realizar un drenaje quirúrgico, siempre que sea posible realizar la incisión en la zona más distal con respecto al pezón para disminuir la probabilidad de dañar conductos y proporcionar una mayor comodidad para amamantar. Hay que tener en cuenta que el drenaje por punción ecoguiada lo realizan habitualmente los ginecólogos/as o radiólogos/as intervencionistas. El drenaje quirúrgico lo realizan ginecólogos/as o cirujanos/as (2).

Fármacos analgésicos seguros durante la lactancia

Durante la lactancia materna es posible que la madre precise la ingesta de medicación analgésica, ya sea por un cuadro de dolor agudo o crónico agudizado. A continuación, se describirán los fármacos analgésicos que se consideran seguros en la madre lactante (12).

AINES

La difusión de los AINES hacia la leche materna es limitada por su elevado estado de ionización y el grado elevado de unión a proteínas. Se considera el ibuprofeno de uso seguro durante la lactancia, por haber información suficiente publicada en la literatura científica o por tener más de una de las siguientes características: falta de toxicidad demostrada, uso frecuente en neonatos o lactantes pequeños sin efecto secundarios, consumo habitual o tradicional extenso, farmacocinética muy favorable y consenso de expertos. Puede tomarse con amplio margen de seguridad.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que como estos fármacos (el naproxeno, ibuprofeno e indometacina) van a producir un desplazamiento de la bilirrubina, estarán contraindicados en las madres de neonatos que presenten ictericia. No obstante, se debe evitar la administración de grandes dosis de AINES durante la LM, ya que hay un riesgo aumentado de intoxicación y sangrado asociado al salicilato (13).

Respecto a la aspirina, se debe ser prudente con su uso prolongado durante la LM, ya que el salicilato es excretado por el neonato de forma muy lenta.

Con la indometacina se ha descrito algún caso de convulsiones o nefrotoxicidad, pero, actualmente, es considerada segura, ya que no se ha establecido una relación causal de dicho efecto. También es considerado seguro el ibuprofeno, encontrándose bajas concentraciones en la leche materna *(Figura 11).*

Del diclofenaco, tras su administración oral materna, se han descrito niveles en sangre del neonato entre el 0,16-0,40 %. Aunque no se disponen de muchos estudios de su administración durante la LM, se considera segura su administración.

Analgésicos no opiáceos

El paracetamol se ha utilizado para la analgesia postoperatoria y para la fiebre materna. El paso a la leche es escaso y parece ser menor que la dosis habitual administrada a los lactantes. En un estudio se demostró que los lactantes solo recibían como máximo el 2 % de la dosis materna ajustada por el peso. Se ha constatado que la hepatotoxicidad es menos frecuente en los recién nacidos, debido a las bajas concentraciones de enzimas específicas del citocromo P-450 que convierten el fármaco en sus metabolitos tóxicos (14).

Algunos analgésicos con riesgo elevado, pero sin evidencia clínica altamente demostrada, son el metamizol, por posible agranulocitosis y la relación con leucemia en el niño, no (ASA) antiagregante, debido al Síndrome de Reye (14).

Antidepresivos

Otro de los fármacos que se utilizan con bastante frecuencia para tratar el dolor neuropático son los antidepresivos, los cuales presentan unos niveles en leche materna bajos. De elección en la LM, se aconseja la amitriptilina, nortriptilina, desipramina, clomipramina y sertralina, ya que los niveles detectados en leche materna son aproximadamente 1 % y, si la madre los precisa, no deben ser interrumpidos. Solo se admite el uso en madres lactantes utilizando dosis moderadas. Sin embargo, con otros antidepresivos se han descrito algunos efectos adversos; como con la fluoxetina, con la que se han documentado casos de nerviosismo y convulsiones en lactantes; así como con la doxepina, con la que se ha descrito algún caso de sedación y depresión respiratoria (15).

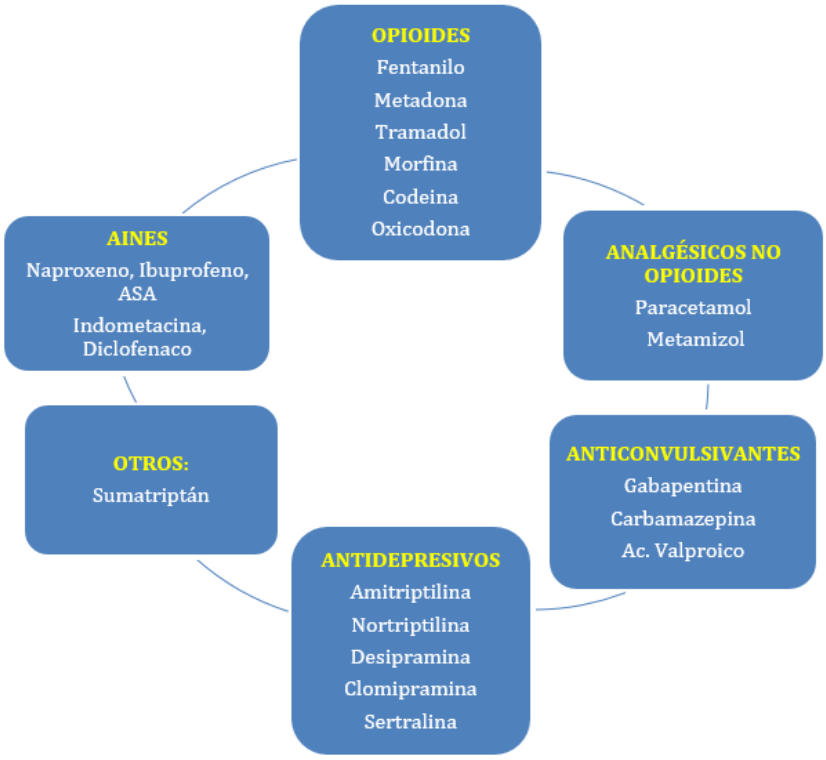

Figura 11. Fármacos seguros durante la lactancia.

Anticonvulsivantes

Los anticonvulsivantes son otro grupo de fármacos utilizados para el manejo del dolor neuropático. La gabapentina, antiepiléptico de nueva generación, se considera seguro, aunque sus resultados en LM son también limitados.

Respecto a los anticonvulsivantes que son metabolizados por uridinadifosfato glucuroniltransferasa (UGT), se debe ser precavidos en su administración, ya que su metabolismo en el lactante está reducido. En general, los antiepilépticos de 2ª generación (carbamazepina, ácido valproico) durante la LM se consideran seguros, por las bajas concentraciones encontradas en sangre del lactante, aunque los estudios disponibles son escasos. No obstante, se han notificado algunos casos de toxicidad hepática en lactantes con la carbamazepina, así como de trombocitopenia y anemia con el ácido valproico.

- **Gabapentina:** es uno de los fármacos de primera línea para el tratamiento del dolor neuropático. También se usa como parte de una pauta de analgesia multimodal en el período perioperatorio. Algunos estudios han indicado la presencia de concentraciones séricas bajas en lactantes de madres que tomaban hasta 2 g al día. Se recomienda vigilar al lactante para detectar aumento de peso y somnolencia. Es probable que la gabapentina sea segura, especialmente en dosis únicas o a corto plazo (16).
- **Pregabalina:** también se utiliza en el tratamiento del dolor neuropático y postoperatorio. Se dispone de información limitada sobre el paso de este medicamento a la leche materna, pero la DRL es del 7 %–8 %. LactMed recomienda vigilar a los lactantes para detectar somnolencia y recomienda usar posibles medicamentos alternativos si se dispone de ellos (17).

Analgésicos opioides

Los opioides se utilizan con frecuencia durante las intervenciones quirúrgicas como parte de una técnica anestésica equilibrada y pueden mantenerse en el período postoperatorio para aliviar el dolor. Todos los opioides pasan a la leche materna en cantidades variables, y las diferencias en la concentración en la leche, junto con la variación de la disponibilidad oral, hacen que determinados tipos de estos medicamentos sean más o menos seguros para una madre lactante. En general, los opioides de cualquier tipo deben utilizarse con precaución y durante el menor tiempo razonable en una madre lactante.

Los opioides se administran por vía intravenosa durante la intervención quirúrgica y pueden administrarse por vía oral una vez que las madres toleran el consumo oral en el postoperatorio. Se pueden administrar por vía intravenosa u oral dos medicamentos específicos, empleados con frecuencia durante el período perioperatorio: morfina e hidromorfona.

Como su disponibilidad oral es bastante escasa, la American Academy of Pediatrics (AAP) los ha identificado como posibles opciones más seguras para las madres lactantes que otros opioides. En general, los opioides intravenosos utilizados durante la intervención quirúrgica se consideran seguros para reanudar inmediatamente la lactancia materna en cuanto las madres estén despiertas en la sala de recuperación.

Medicamentos intravenosos

- **Morfina:** se sigue considerando una opción razonable para las madres lactantes debido a su transporte limitado a la leche y a su escasa disponibilidad oral. Con la administración de morfina, existe controversia en el porcentaje de este fármaco que es excretado por leche materna, por lo que algunos autores sí lo recomiendan en la LM, mientras que otros recomiendan precaución en su administración. También puede causar galactorrea e incremento de prolactina
- **Fentanilo:** se han estudiado las concentraciones de fentanilo en la leche materna y son extremadamente bajas después de 2 horas, en general, por debajo del límite de detección. También tiene una disponibilidad oral muy baja y es improbable que cause efectos importantes por su baja concentración en la leche materna. Su uso hospitalario suele estar restringido al quirófano, al servicio de urgencias o a las áreas de cuidados intensivos, debido a su potencia y al rápido inicio de la acción.
- **Hidromorfona:** se dispone de dos informes sobre hidromorfona y la lactancia, pero en ninguno de ellos se evalúa su uso por vía intravenosa. Un estudio en el que se evaluó una dosis intranasal única de hidromorfona 2 mg reveló que los lactantes recibirían una DRL del 0,67 %.
- **Petidina:** la transferencia de petidina a la leche materna es escasa (1,7 %–3,5 % de la dosis materna ajustada en función del peso). Sin embargo, petidina y su metabolito (norpetidina) producen sistemáticamente sedación neonatal relacionada con la dosis. Se han documentado paso a la leche y sedación neonatal hasta 36 horas después de una dosis única. En los lactantes de madres expuestas a dosis múltiples de petidina hay que vigilar estrechamente la aparición de sedación, cianosis, bradicardia y, posiblemente, crisis convulsivas. La AAP recomienda su uso en madres lactantes.
- **Medicamentos orales para el dolor postoperatorio:** todos los opioides orales utilizados para el dolor postoperatorio deben limitarse al ciclo razonable más corto, y hay que vigilar estrechamente a los lactantes por si aparece sedación cuando las madres necesiten estos medicamentos. Los efectos analgésicos de codeína y tramadol proceden de metabolitos que dependen de la actividad de la CYP2D6. La variación interindividual de la actividad de la CYP2D6 puede provocar que los metabolizadores ultrarrápidos reciban cantidades excesivamente elevadas de metabolitos activos, lo que podría causar sedación o depresión respiratoria con la administración habitual. Aunque hidrocodona y oxicodona también son parcialmente metabolizadas por la CYP2D6 a metabolitos más potentes, el fármaco original también ejerce un efecto analgésico y hay menos preocupación por los efectos clínicos de la variación del metabolismo.
- **Hidrocodona:** se ha utilizado con frecuencia en madres lactantes. Se han documentado casos ocasionales de sedación neonatal, pero son raros y generalmente estaban relacionados con la dosis. Las dosis en madres lactantes deben limitarse a 30 mg al día.
- **Tramadol:** es un opioide débil con actividad adicional en receptores centrales de noradrenalina y serotonina. Al igual que codeína, tiene que ser metabolizado por la CYP2D6 en un metabolito activo para ejercer sus efectos analgésicos. Con una DIL del <1 % del metabolito activo y sin efectos descritos en lactantes alimentados al pecho. Antes se consideraba una opción segura para las madres lactantes. Sin embargo, la FDA ha desaconsejado el uso de este medicamento en madres lactantes en los Estados Unidos. El tramadol se caracteriza por: Riesgo muy bajo para la lactancia, es seguro, compatible, mínimo riesgo para la lactancia y el lactante. Es un analgésico de acción central con débil efecto opioide y propiedades noradrenérgica y serotoninérgicas. Indicado para tratar dolor moderado a intenso. La dosis recibida a través de la leche materna es muy inferior a la dosis utilizada en recién nacidos y lactantes y no se han observado problemas en lactantes de madres que lo tomaban. Los niveles en plasma de estos lactantes son muy bajos en comparación a lo constatado cuando el bebé lo usa. Por todo ello, Palmer (2018) estima inapropiada esta contraindicación de la FDA de su ingesta durante la lactancia materna (18).

Otros fármacos utilizados para el dolor

Los triptanes son fármacos que se utilizan para el tratamiento de las cefaleas. Aunque los estudios disponibles en mujeres lactantes son escasos, se dispone de algún estudio con el sumatriptán, que, a pesar de su paso a leche materna, generalmente suele ser administrado a bajas dosis y de forma esporádica, por lo que no se han descrito efectos secundarios en lactantes, y se considera seguro durante la LM. Sin embargo, con el resto de triptanes, como no se dispone de datos, algunos autores recomiendan retrasar la lactancia 24 h tras su administración.

En general, la mayoría de los fármacos analgésicos son seguros y podrían utilizarse durante la LM, aunque no se disponen de datos concluyentes en la mayoría de los medicamentos. Es por ello que se deben valorar los riesgos y beneficios de forma individualizada en cada paciente, evitando, en lo posible, la retirada de la LM.

Bibliografía

1. Machado Solano AM, Guerra Domínguez E, Carrazana Fonseca I, Sánchez Corrales DR. Uso de medicamentos y fitofármacos en madres durante periodo de lactancia. Multimed 2019; 23(5). VERSION ON-LINE: ISSN 1028-4818.
2. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna. Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco-OSTEBA, 2017. Guías de Práctica Clínica en el SNS.
3. Recomendaciones sobre lactancia maternal. Comité de Lactancia Materna · Asociación Española de Pediatría, 2012. p:1-13. www.e-lactancia. Org.
4. Santana M, Basteiro E, Rico V, Illa M, Palacio M, Cobo T. Mastitis aguda y abceso mamario puerperal. Centre de Medicina Fetal. Neonatal de Barcelona, Clínic Barcelona Hospital Universitari. 2021: p 1-9. www.medicinafetalbarcelona.org.
5. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect Victora, Cesar G et al. The Lancet, Volume 387, Issue 10017, 475 – 490.
6. Parri Ferrandis FJ. Anquiloglosia en el lactante. Aspectos quirúrgicos. Cir Pediatr. 2021; 34: 59-62
7. IAPD Foundational Articles and Consensus Recommendations: Management of Ankyloglossia, 2021. http://www.iapdworld.org/2021_08_management-of-ankyloglossia.
8. NICE. Postnatal care up to 8 weeks after birth. Julio 2006 (actualizado en Febrero de 2015). Disponible en: http://guidance.nice.org.uk/CG37
9. Osejo Rodríguez MS; Maya Cancino A, Brenes Meseguer N. Actualización de la clasificación y manejo de mastitis. Revista Médica Sinergia Vol.5 (6), Junio 2020 - ISSN:2215-4523 / e-ISSN:2215-5279 http://revistamedicasinergia.com
10. Santana M, Basteiro E, Rico V, Illa M, Palacio M, Cobo T. Mastitis aguda y abceso mamario puerperal. Centre de Medicina Fetal. Neonatal de Barcelona, Clínic Barcelona Hospital Universitari. 2021: p 1-9. www.medicinafetalbarcelona.org
11. Association of Breastfeeding Medicine. (ABM). (2020). Protocolo Clínico de la ABM, Mastitis. Revisión. Breastfeeding Medicine, 15(1), 2020. En: www.bfmed.org/Media/Files/Protocols/VERSION FINAL PROTOCOLO 4_Spanish.pdf
12. Reece-Stremtan S, Campos M, Kokajko L. Protocolo clínico de la ABM n.º 15: Analgesia y anestesia en la madre lactante, modificado en 2017 BREASTFEEDING MEDICINE 2017. Volumen 12, Número 9. P:1-6. DOI: 10.1089/bfm.2017.29054.srt
13. APILAM. Ibuprofeno. En:e-lactancia.org. APILAM: Asociación para la promoción e investigación científica y cultural de la lactancia materna; 2002 actualizado 16 may 2021; acceso 01 ago 2021. Disponible en http://e-lactancia.org/breastfeedin/ibuprofen/product/
14. APILAM. Paracetamol. En: e-lactancia.org. APILAM: Asociación para la promoción e investigación científica y cultural de la lactancia materna; 2002 actualizado 13 jun 2021; acceso 01 ago 2021. Disponible en http://e-lactancia.org/breastfeedin/ibuprofen/product/
15. C. Carnero-Pardo, S. Lopez-Alcalde, M. Florido-Santiago, M. Espinosa-García, I. Rego-García R. Calle-Calle, I. Carrera-Muñoz, R de la Vega-Cotarelo- Utilidad diagnóstica y validez predictiva del uso conjunto de Fototest y Mini-Cog en deterioro cognitivo. Neurología 2021; digital object identifier. Doi: 10.1016/j.nrl.2021.01.017
16. National Library of Medicine. Gabapentin. In: Drugs and lactation database (LactMed). Updated 2017. Available at https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2 (accessed May 18, 2017).
17. Comité de medicamentos de la Asociación Española de la Pediatria. Pediamécum. Edición 2015. ISSN 2531-2464. Disponible en: https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum/pregabalina. Actualizado septiembre 2020.
18. APILAM. Tramadol. En: e-lactancia.org. APILAM: Asociación para la promoción e investigación científica y cultural de la lactancia materna; 2002 actualizado 24 de ago 2019; acceso 01 ago 2021. Disponible en http://e-lactancia.org/breastfeedin/ibuprofen/product/